ΜΠΟΝΟΥΣ 3

Γνωμάτευση με Βάση το Κλινικό Ερώτημα: 30 Κλινικά Ερωτήματα

Όποιο κι αν είναι το ερώτημα του παραπεμπτικού, η πρώτη πρόταση της γνωμάτευσής σας πρέπει να απαντά σε αυτό. Για τα 30 συχνότερα κλινικά ερωτήματα: τι πρέπει οπωσδήποτε να απαντά η γνωμάτευση, η αρνητική πρόταση και η θετική πρόταση.

Περιεχόμενα

Γιατί το κλινικό ερώτημα έρχεται πρώτο

Νευροακτινολογία — 5 ερωτήματα

Θώρακας — 7 ερωτήματα

Κοιλία και πύελος — 10 ερωτήματα

Αγγειακά — 3 ερωτήματα

Μυοσκελετικό και σπονδυλική στήλη — 5 ερωτήματα

Επόμενο βήμα

ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

Γιατί το κλινικό ερώτημα έρχεται πρώτο

Στο βήμα ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ διαβάζετε το παραπεμπτικό· στο βήμα ΣΥΝΟΨΙΣΤΕ του απαντάτε.

> *Ο ιατρός που έγραψε το παραπεμπτικό, όταν ανοίγει τη γνωμάτευση, αναζητά ένα μόνο πράγμα: την απάντηση στο ερώτημά του. Αν δεν τη βρει, τηλεφωνεί ή παρερμηνεύει τη γνωμάτευση.*

1. **Διαβάστε το παραπεμπτικό και συμπυκνώστε το ερώτημα σε μία λέξη** — «σκωληκοειδίτιδα;», «αιμορραγία;», «λίθος;».

2. **Κάντε πάντα πλήρη τη σάρωσή σας** — το ερώτημα δίνει εστίαση, αλλά οι άλλες περιοχές δεν παραλείπονται.

3. **Καλύψτε στα Ευρήματα τη λίστα «οπωσδήποτε» του ερωτήματος** — κάθε σημείο γράφεται είτε ως θετικό είτε ως σημαντικό αρνητικό εύρημα.

4. **Η πρώτη πρόταση του Συμπεράσματος είναι η απάντηση στο ερώτημα** — αν είναι θετικό, το εύρημα και, εφόσον χρειάζεται, ενημέρωση· αν είναι αρνητικό, σαφής αρνητική πρόταση.

5. **Γράψτε τον περιορισμό** — όταν η εξέταση δεν επαρκεί για να αποκλείσει το ερώτημα, αναφέρετέ το ρητά.

Αν το παραπεμπτικό είναι ασαφές

Σε ασαφή παραπεμπτικά όπως «έλεγχος», «πόνος», προσπαθήστε να μάθετε τις κλινικές πληροφορίες από τον φάκελο ή από τον ιατρό που έγραψε το παραπεμπτικό. Αν δεν τα καταφέρετε, δομήστε τη γνωμάτευση με βάση το πιθανότερο ερώτημα και απαντήστε μία-μία στις συχνές αιτίες.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Νευροακτινολογία

5 κλινικά ερωτήματα

01 «Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο;»

Συνήθης εξέταση: Αξονική τομογραφία εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό ± αξονική αγγειογραφία· μαγνητική DWI

Η ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΑΠΑΝΤΑ

- Υπάρχει αιμορραγία ή όχι (πρώτη πρόταση)
- Πρώιμα σημεία ισχαιμίας και αγγειακή περιοχή
- Σημείο υπέρπυκνης αρτηρίας
- Εφόσον έγινε αξονική αγγειογραφία, απόφραξη μεγάλου αγγείου
- Ώρα ενημέρωσης

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Δεν διαπιστώθηκε ενδοκράνια αιμορραγία. Δεν παρατηρούνται πρώιμες ισχαιμικές αλλοιώσεις· το πρώιμο ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να μη φαίνεται στην αξονική τομογραφία χωρίς σκιαγραφικό.

ΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Χωρίς ενδοκράνια αιμορραγία· [δεξιά/αριστερά] αγγειακή περιοχή της MCA: πρώιμα σημεία οξείας ισχαιμίας. Στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου [ώρα]: έγινε ενημέρωση.

02 «Κρανιοεγκεφαλική κάκωση — αιμορραγία;»

Συνήθης εξέταση: Αξονική τομογραφία εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό (παράθυρο εγκεφάλου και οστικό παράθυρο)

Η ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΑΠΑΝΤΑ

- Εξωαξονική και ενδοπαρεγχυματική αιμορραγία
- Πιεστική επίδραση και μετατόπιση της μέσης γραμμής (mm)
- Βασικές δεξαμενές
- Κάταγμα θόλου και βάσης κρανίου
- Πνευμοεγκέφαλος

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Δεν διαπιστώθηκε οξεία ενδοκράνια αιμορραγία, πιεστική επίδραση ή κάταγμα του θόλου του κρανίου.

ΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
[Δεξιά/Αριστερά] οξύ [επισκληρίδιο/υποσκληρίδιο] αιμάτωμα· [.. mm] μετατόπιση της μέσης γραμμής. [Ώρα]: έγινε ενημέρωση.

03 «Αιφνίδια έντονη κεφαλαλγία — υπαραχνοειδής αιμορραγία;»

Συνήθης εξέταση: Αξονική τομογραφία εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό ± αξονική αγγειογραφία

Η ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΑΠΑΝΤΑ

- Υπαραχνοειδής αιμορραγία και κατανομή της
- Υδροκέφαλος
- Ενδοκοιλιακή ή ενδοπαρεγχυματική αιμορραγία
- Σύσταση για αξονική αγγειογραφία στο ανεύρυσμα

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Δεν διαπιστώθηκε υπαραχνοειδής αιμορραγία. Η ευαισθησία της αξονικής μειώνεται όσο περνά ο χρόνος από την έναρξη· αν η κλινική υποψία παραμένει, η περαιτέρω διερεύνηση αφήνεται στην κλινική κρίση.

ΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
[Στις βασικές δεξαμενές] υπαραχνοειδής αιμορραγία· υδροκέφαλος **[όχι/ναι]**. Προτείνεται αξονική αγγειογραφία. **[Ώρα]**: έγινε ενημέρωση.

04 «Μάζα;»

Συνήθης εξέταση: Μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου με σκιαγραφικό (αν υπάρχει υποψία στην αξονική)

Η ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΑΠΑΝΤΑ

- Αριθμός, θέση και μέγεθος των βλαβών
- Διάκριση ενδοαξονικής/εξωαξονικής
- Οίδημα και πιεστική επίδραση
- Εγκεφαλικός εγκολεασμός
- Πιθανότερη διαφορική διάγνωση

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Στη μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου με σκιαγραφικό δεν διαπιστώθηκε χωροκατακτητική βλάβη ή παθολογική ενίσχυση.

ΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
[Δεξιά/Αριστερά] **[λοβός]**: **[.. mm]** **[ενδοαξονική/εξωαξονική]** μάζα· **[διαφορική διάγνωση]**. Σημεία εγκολεασμού **[όχι/ναι]**.

05 «Υδροκέφαλος / δυσλειτουργία βαλβίδας παροχέτευσης;»

Συνήθης εξέταση: Αξονική τομογραφία εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό· σύγκριση με την προηγούμενη εξέταση

Η ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΑΠΑΝΤΑ

- Μεταβολή του μεγέθους των κοιλιών σε σχέση με την προηγούμενη εξέταση
- Περικοιλιακό οίδημα
- Θέση του άκρου του καθετήρα της βαλβίδας παροχέτευσης
- Αιμορραγία

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Σε σύγκριση με την προηγούμενη εξέταση δεν παρατηρείται μεταβολή στο μέγεθος των κοιλιών· άκρο του καθετήρα της βαλβίδας παροχέτευσης **[θέση]**.

ΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Σε σύγκριση με την προηγούμενη εξέταση, σαφής διάταση των κοιλιών· μπορεί να είναι υπέρ δυσλειτουργίας της βαλβίδας παροχέτευσης. **[Ώρα]**: έγινε ενημέρωση.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Θώρακας

7 κλινικά ερωτήματα

06 «Πνευμοθώρακας;»

Συνήθης εξέταση: Ακτινογραφία θώρακα· εφόσον χρειάζεται, αξονική ή POCUS

Η ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΑΠΑΝΤΑ

- Υπάρχει πνευμοθώρακας; Πλευρά
- Μέτρηση ή ποσότητα
- Ευρήματα υπέρ πνευμοθώρακα υπό τάση
- Συνοδά κατάγματα πλευρών, υποδόριο εμφύσημα

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Δεν διαπιστώθηκε πνευμοθώρακας.

ΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
[Δεξιά/Αριστερά] πνευμοθώρακας, στην κορυφή [.. mm]· ευρήματα υπέρ πνευμοθώρακα υπό τάση [όχι/ναι]. [Ώρα]: έγινε ενημέρωση.

07 «Πνευμονία;»

Συνήθης εξέταση: Ακτινογραφία θώρακα· εφόσον χρειάζεται, αξονική τομογραφία θώρακα

Η ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΑΠΑΝΤΑ

- Υπάρχει πύκνωση; Λοβός/τμήμα
- Πλευριτική συλλογή
- Σηράγγωση ή απόστημα
- Μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη εξέταση

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Δεν διαπιστώθηκε πύκνωση του πνευμονικού παρεγχύματος υπέρ πνευμονίας.

ΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
[Δεξιά/Αριστερά] [λοβός] πύκνωση· σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα μπορεί να είναι συμβατή με πνευμονία. Πλευριτική συλλογή [όχι/ναι].

08 «Πνευμονική εμβολή;»

Συνήθης εξέταση: Αξονική πνευμονική αγγειογραφία

Η ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΑΠΑΝΤΑ

- Επάρκεια της σκιαγράφησης
- Υπάρχει εμβολή και ποιο είναι το πιο κεντρικό επίπεδο;
- Υπερφόρτωση δεξιάς κοιλίας
- Εναλλακτική διάγνωση (πνευμονία, συλλογή)

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Η σκιαγράφηση της πνευμονικής αρτηρίας είναι επαρκής· δεν διαπιστώθηκε πνευμονική θρομβοεμβολή.

ΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
[Αμφοτερόπλευρη] [λοβιακή/τμηματική] οξεία πνευμονική θρομβοεμβολή· υπερφόρτωση δεξιάς κοιλίας [όχι/ναι]. [Ώρα]: έγινε ενημέρωση.

09 «Διαχωρισμός αορτής;»

Συνήθης εξέταση: Αξονική αγγειογραφία (χωρίς σκιαγραφικό + αρτηριακή φάση)

Η ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΑΠΑΝΤΑ

- Υπάρχει διαχωρισμός;
- Συμμετοχή της ανιούσας αορτής
- Συμμετοχή κλάδων και αιμάτωση οργάνων
- Περικαρδιακή συλλογή, αιμάτωμα μεσοθωρακίου
- Ενδοτοιχωματικό αιμάτωμα

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Δεν διαπιστώθηκε διαχωρισμός αορτής, ενδοτοιχωματικό αιμάτωμα ή διεισδυτικό έλκος.

ΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
[Stanford A/B] διαχωρισμός αορτής· [συμμετοχή κλάδων]. Επείγον εύρημα· [ώρα]: έγινε ενημέρωση.

10 «Θέση σωλήνα / καθετήρα;»

Συνήθης εξέταση: Ακτινογραφία θώρακα ΑΡ στην κλίνη

Η ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΑΠΑΝΤΑ

- Πού βρίσκεται το άκρο κάθε συσκευής
- Απόσταση του ΕΤΤ από την τρόπιδα
- Αν ο ρινογαστρικός σωλήνας βρίσκεται εντός του στομάχου
- Πνευμοθώρακας λόγω της επέμβασης

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Το άκρο του ΕΤΤ βρίσκεται [.. cm] πάνω από την τρόπιδα, το άκρο του ρινογαστρικού σωλήνα στην προβολή του στομάχου, το άκρο του ΚΦΚ στην προβολή της άνω κοίλης φλέβας· χωρίς πνευμοθώρακα.

ΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
[Άκρο του ρινογαστρικού σωλήνα στην προβολή του δεξιού κύριου βρόγχου], δεν βρίσκεται σε κατάλληλη θέση. Πριν από τη χρήση — [ώρα]: έγινε ενημέρωση.

11 «Καρδιακή ανεπάρκεια / πνευμονικό οίδημα;»

Συνήθης εξέταση: Ακτινογραφία θώρακα· υπερηχογράφημα πνευμόνων

Η ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΑΠΑΝΤΑ

- Μέγεθος καρδιάς (με αναφορά της προβολής)
- Αγγειακή συμφόρηση και διάμεσο οίδημα
- Πλευριτική συλλογή
- Μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη εξέταση

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Δεν διαπιστώθηκαν ευρήματα υπέρ πνευμονικού οιδήματος ή πλευριτικής συλλογής.

ΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Ευρήματα υπέρ πνευμονικού οιδήματος και μικρή αμφοτερόπλευρη πλευριτική συλλογή· σε σύγκριση με την προηγούμενη εξέταση **[αύξηση/υποχώρηση]**.

12 «Πλευριτική συλλογή;»

Συνήθης εξέταση: Ακτινογραφία θώρακα· υπερηχογράφημα θώρακα

Η ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΑΠΑΝΤΑ

- Υπάρχει συλλογή; Πλευρά
- Ποσότητα
- Περιεχόμενο (υπερηχογράφημα: άνηχο, με διαφραγμάτια, ηχογενές)
- Υποκείμενη παθολογία του παρεγχύματος
- Κατάλληλο παράθυρο για επέμβαση (εφόσον ζητείται)

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Δεν διαπιστώθηκε πλευριτική συλλογή.

ΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
[Δεξιά/Αριστερά] **[μικρής/μέτριας/μεγάλης]** ποσότητας **[άνηχη/με επιπλεγμένη εικόνα]** πλευριτική συλλογή.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Κοιλία και πύελος

10 κλινικά ερωτήματα

13 «Σκωληκοειδίτιδα;»

Συνήθης εξέταση: Παιδί/νέος/έγκυος: υπερηχογράφημα· ενήλικας: αξονική τομογραφία με σκιαγραφικό

Η ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΑΠΑΝΤΑ

- Απεικονίστηκε η σκωληκοειδής απόφυση;
- Διάμετρος, τοίχωμα, περιβάλλων λιπώδης ιστός
- Κοπρόλιθος σκωληκοειδούς
- Διάτρηση, απόστημα
- Αν δεν απεικονίστηκε, ότι αυτό δεν αποκλείει τη σκωληκοειδίτιδα

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Η σκωληκοειδής απόφυση απεικονίζεται με φυσιολογική εικόνα· δεν διαπιστώθηκαν ευρήματα υπέρ οξείας σκωληκοειδίτιδας.

ΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Ευρήματα συμβατά με οξεία σκωληκοειδίτιδα· διάτρηση ή απόστημα **[όχι/ναι]**. **[Ώρα]**: έγινε ενημέρωση.

14 «Λίθος; (νεφρικός κολικός)»

Συνήθης εξέταση: Αξονική τομογραφία χωρίς σκιαγραφικό (πρωτόκολλο λιθίασης)· υπερηχογράφημα

Η ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΑΠΑΝΤΑ

- Υπάρχει λίθος; Θέση και μέγεθος (mm)
- Βαθμός υδρονέφρωσης
- Ετερόπλευρος νεφρός
- Εναλλακτική διάγνωση

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Δεν διαπιστώθηκε λίθος ή υδρονέφρωση στο ουροποιητικό σύστημα.

ΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
[Δεξιά/Αριστερά] **[άπω]** ουρητήρας: **[.. mm]** λίθος και **[ήπια]** υδρουρητηρονέφρωση.

15 «Χολοκυστίτιδα;»

Συνήθης εξέταση: Υπερηχογράφημα κοιλίας

Η ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΑΠΑΝΤΑ

- Λίθος
- Πάχος τοιχώματος και περιχολοκυστικό υγρό
- Υπερηχογραφικό σημείο Murphy
- Εύρος χοληδόχου πόρου
- Επιπλοκή (γάγγραινα, διάτρηση)

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Χοληδόχος κύστη φυσιολογική· δεν διαπιστώθηκαν λίθοι ή ευρήματα οξείας χολοκυστίτιδας. Χοληδόχος πόρος [.. mm].

ΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Ευρήματα συμβατά με οξεία λιθιασική χολοκυστίτιδα· χοληδόχος πόρος [.. mm]. [Ώρα]: έγινε ενημέρωση.

16 «Απόφραξη / ειλεός;»

Συνήθης εξέταση: Απλή ακτινογραφία κοιλίας σε όρθια θέση· αξονική τομογραφία κοιλίας με σκιαγραφικό

Η ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΑΠΑΝΤΑ

- Υπάρχει απόφραξη; Λεπτό/παχύ έντερο
- Σημείο μετάβασης και πιθανή αιτία
- Ευρήματα στραγγαλισμού/ισχαιμίας
- Ελεύθερος αέρας

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Δεν διαπιστώθηκαν ευρήματα υπέρ μηχανικής απόφραξης του εντέρου.

ΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
[Περιοχή]: μηχανική απόφραξη λεπτού εντέρου με σημείο μετάβασης· σημεία ισχαιμίας [όχι/ναι].

17 «Διάτρηση / ελεύθερος αέρας;»

Συνήθης εξέταση: Ακτινογραφία θώρακα σε όρθια θέση· αξονική τομογραφία κοιλίας

Η ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΑΠΑΝΤΑ

- Υπάρχει ελεύθερος αέρας;
- Πιθανό σημείο διάτρησης
- Ελεύθερο υγρό, απόστημα
- Πρόσφατο χειρουργικό ιστορικό

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Δεν διαπιστώθηκε ελεύθερος αέρας.

ΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Πνευμοπεριτόναιο· [πιθανή εντόπιση] — ευρήματα υπέρ διάτρησης σε αυτή τη θέση. [Ώρα]: έγινε ενημέρωση.

18 «Παγκρεατίτιδα / επιπλοκή;»

Συνήθης εξέταση: Αξονική τομογραφία κοιλίας με σκιαγραφικό (συνήθως λίγο μετά την έναρξη των συμπτωμάτων)

Η ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΑΠΑΝΤΑ

- Τύπος παγκρεατίτιδας (οιδηματώδης/νεκρωτική)
- Περιπαγκρεατικό υγρό ή συλλογή
- Αγγειακή επιπλοκή
- Χολολιθίαση

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Δεν διαπιστώθηκαν ευρήματα υπέρ οξείας παγκρεατίτιδας.

ΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Οξεία **[νεκρωτική]** παγκρεατίτιδα· **[συλλογή/αγγειακή επιπλοκή]** **[όχι/ναι]**.

19 «Τραύμα — κάκωση συμπαγούς οργάνου;»

Συνήθης εξέταση: Αξονική τομογραφία τραύματος με σκιαγραφικό· FAST

Η ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΑΠΑΝΤΑ

- Κάθε συμπαγές όργανο ένα-ένα
- Αιμοπεριτόναιο και ποσότητα
- Ενεργός διαφυγή σκιαγραφικού
- Κάκωση εντέρου/μεσεντερίου
- Οστικές κακώσεις

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Δεν διαπιστώθηκαν ευρήματα υπέρ κάκωσης συμπαγούς οργάνου, ελεύθερου υγρού ή ενεργού αιμορραγίας.

ΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
[Όργανο] — κάκωση και αιμοπεριτόναιο· ενεργός διαφυγή σκιαγραφικού **[όχι/ναι]**. **[Ώρα]**: έγινε ενημέρωση.

20 «Έκτοπη κύηση;»

Συνήθης εξέταση: Διακολπικό και διακοιλιακό υπερηχογράφημα πυέλου

Η ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΑΠΑΝΤΑ

- Υπάρχει ενδομήτρια κύηση;
- Μάζα εξαρτημάτων
- Ελεύθερο υγρό και περιεχόμενό του
- Κατάσταση των ωοθηκών

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Στην ενδομήτρια κοιλότητα παρατηρείται σάκος κύησης **[με λεκιθικό ασκό]** — δεν διαπιστώθηκε μάζα εξαρτημάτων ή ελεύθερο υγρό.

ΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Δεν παρατηρείται ενδομήτρια κύηση· **[δεξιά/αριστερά]** μάζα εξαρτημάτων και ελεύθερο υγρό, ευρήματα υπέρ έκτοπης κύησης. **[Ώρα]**: έγινε ενημέρωση.

21 «Εκκολπωματίτιδα;»

Συνήθης εξέταση: Αξονική τομογραφία κοιλίας-πυέλου με σκιαγραφικό

Η ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΑΠΑΝΤΑ

- Τμήμα που προσβάλλεται
- Είναι επιπλεγμένη (απόστημα, διάτρηση, συρίγγιο);
- Μέγεθος αποστήματος
- Εναλλακτική διάγνωση

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Δεν διαπιστώθηκαν ευρήματα υπέρ εκκολπωματίτιδας.

ΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
[Σιγμοειδές] κόλον: οξεία [επιπλεγμένη/μη επιπλεγμένη] εκκολπωματίτιδα· απόστημα [όχι/ναι, .. mm].

22 «Κοιλιακό άλγος — αιτία;»

Συνήθης εξέταση: Αξονική τομογραφία κοιλίας-πυέλου με σκιαγραφικό ή υπερηχογράφημα

Η ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΑΠΑΝΤΑ

- Υπάρχει οξεία χειρουργική παθολογία;
- Οι συχνές αιτίες μία-μία: σκωληκοειδής απόφυση, χοληδόχος κύστη, έντερο, ουροποιητικό σύστημα
- Ελεύθερο υγρό και ελεύθερος αέρας
- Αγγειακή παθολογία (αορτή)

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Δεν διαπιστώθηκε οξεία παθολογία που να εξηγεί το κοιλιακό άλγος.

ΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
[Εύρημα]· μπορεί να εξηγεί το κοιλιακό άλγος. [Ενημέρωση εφόσον χρειάζεται].

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Αγγειακά

3 κλινικά ερωτήματα

23 «DVT;»

Συνήθης εξέταση: Υπερηχογράφημα Doppler φλεβών κάτω άκρων

Η ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΑΠΑΝΤΑ

- Ποια τμήματα εκτιμήθηκαν
- Συμπιεστότητα
- Κεντρικό όριο του θρόμβου
- Εκτιμήθηκαν οι φλέβες της γαστροκνημίας;

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

[Δεξιά/Αριστερά] κάτω άκρο: στις εν τω βάθει φλέβες [στα τμήματα που εκτιμήθηκαν] δεν διαπιστώθηκε θρόμβωση.

ΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

[Δεξιά/Αριστερά] [μηροϊγνυακό] τμήμα: οξεία DVT· κεντρικό όριο [επίπεδο]. [Ώρα]: έγινε ενημέρωση.

24 «Συστροφή όρχεος;»

Συνήθης εξέταση: Υπερηχογράφημα όσχεου σε κλίμακα του γκρι και έγχρωμο Doppler

Η ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΑΠΑΝΤΑ

- Ενδοορχική αιματική ροή (σε σύγκριση με την αντίθετη πλευρά)
- Μέγεθος και ηχοδομή του όρχεος
- Σπερματικός τόνος
- Εναλλακτική διάγνωση (επιδιδυμίτιδα)

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Η αιματική ροή και στους δύο όρχεις είναι συμμετρική· δεν διαπιστώθηκαν ευρήματα υπέρ συστροφής. Η παρουσία ροής δεν αποκλείει πλήρως τη διαλείπουσα συστροφή.

ΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

[Δεξιά/Αριστερά] όρχις: δεν παρατηρείται αιματική ροή· συμβατό με συστροφή. Επείγον εύρημα· [ώρα]: έγινε ενημέρωση.

25 «ΑΑΑ / ρήξη;»

Συνήθης εξέταση: Υπερηχογράφημα κοιλιακής αορτής· αξονική αγγειογραφία

Η ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΑΠΑΝΤΑ

- Μέγιστη διάμετρος (mm)
- Σχέση με τις νεφρικές αρτηρίες
- Περιαορτικό αιμάτωμα (ρήξη)
- Ο περιορισμός του υπερηχογραφήματος σε συμπτωματικό ασθενή

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Η κοιλιακή αορτή έχει φυσιολογικό εύρος· δεν διαπιστώθηκε ανεύρυσμα.

ΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Υπονεφρικό ΑΑΑ, μέγιστη διάμετρος **[.. mm]**· σημεία ρήξης **[όχι/ναι]**. **[Ώρα]**: έγινε ενημέρωση.

ΕΝΟΤΗΤΑ 5

Μυοσκελετικό και σπονδυλική στήλη

5 κλινικά ερωτήματα

26 «Κάταγμα;»

Συνήθης εξέταση: Απλή ακτινογραφία (τουλάχιστον δύο προβολές)· εφόσον χρειάζεται, αξονική/μαγνητική

Η ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΑΠΑΝΤΑ

- Υπάρχει κάταγμα; Οστό και επίπεδο
- Ενδαρθρική επέκταση
- Παρεκτόπιση, γωνίωση
- Εξάρθρημα
- Πιθανότητα αφανούς κατάγματος αν η ακτινογραφία είναι αρνητική

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Δεν διαπιστώθηκε οξύ κάταγμα ή εξάρθρημα. Αν η κλινική υποψία παραμένει, το αφανές κάταγμα δεν μπορεί να αποκλειστεί με την ακτινογραφία.

ΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
[Δεξιά/Αριστερά] [οστό] [εντόπιση] κάταγμα· [ενδαρθρικό/εξωαρθρικό], [παρεκτόπιση].

27 «Κάταγμα ισχίου; (ηλικιωμένος, πτώση)»

Συνήθης εξέταση: Προσθιοπίσθια πυέλου + πλάγια ισχίου· αν είναι αρνητικές, μαγνητική ή αξονική

Η ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΑΠΑΝΤΑ

- Αυχένας μηριαίου και διατροχαντήρια περιοχή
- Παρεκτόπιση
- Πυελικός δακτύλιος και ηβικοί κλάδοι
- Σύσταση περαιτέρω διερεύνησης για αφανές κάταγμα

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Δεν διαπιστώθηκε οξύ κάταγμα στο ισχίο και στην πύελο. Αν η κλινική υποψία είναι υψηλή, προτείνεται μαγνητική ή αξονική για αφανές κάταγμα.

ΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
[Δεξιά/Αριστερά] κάταγμα αυχένα μηριαίου ([με παρεκτόπιση/χωρίς παρεκτόπιση]).

28 «Πίεση νωτιαίου μυελού / ιππουρίδα;»

Συνήθης εξέταση: Μαγνητική τομογραφία όλης της σπονδυλικής στήλης ή της οσφυϊκής μοίρας

Η ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΑΠΑΝΤΑ

- Υπάρχει πίεση; Επίπεδο και αιτία
- Μεταβολή σήματος στον νωτιαίο μυελό
- Ρίζες της ιππουρίδας
- Επιπλέον επίπεδα

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Δεν διαπιστώθηκε πίεση του νωτιαίου μυελού ή της ιππουρίδας.

ΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
[Στο ύψος του ..] — [αιτία] προκαλεί πίεση του νωτιαίου μυελού. Επείγον εύρημα· [ώρα]: έγινε ενημέρωση.

29 «Κάκωση αυχενικής μοίρας — κάταγμα;»

Συνήθης εξέταση: Αξονική τομογραφία αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης

Η ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΑΠΑΝΤΑ

- Ευθυγράμμιση
- Ευρήματα κατάγματος και αστάθειας
- Κρανιοαυχενική συμβολή
- Προσπονδυλικά μαλακά μόρια
- Ανάγκη μαγνητικής για κάκωση συνδέσμων

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Δεν διαπιστώθηκε οξύ κάταγμα ή διαταραχή ευθυγράμμισης στους αυχενικούς σπονδύλους.

ΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
[Στο ύψος του ..] — [κάταγμα/εξάρθρημα]· όσον αφορά την αστάθεια, [ώρα]: έγινε ενημέρωση.

30 «Σηπτική αρθρίτιδα / οστεομυελίτιδα;»

Συνήθης εξέταση: Απλή ακτινογραφία· υπερηχογράφημα (συλλογή)· μαγνητική

Η ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΑΠΑΝΤΑ

- Υγρό στην άρθρωση
- Συμμετοχή του μυελού των οστών
- Απόστημα μαλακών μορίων
- Ο περιορισμός της απεικόνισης (η ανάγκη παρακέντησης είναι κλινική απόφαση)

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
[Άρθρωση]: δεν διαπιστώθηκε συλλογή· δεν παρατηρούνται αλλοιώσεις του μυελού των οστών υπέρ οστεομυελίτιδας.

ΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
[Άρθρωση]: συλλογή και [οίδημα μυελού των οστών/απόστημα]· προτείνεται επείγουσα κλινική εκτίμηση για σηπτική αρθρίτιδα/οστεομυελίτιδα. [Ώρα]: έγινε ενημέρωση.

Εκπαιδευτικό υλικό. Δεν αντικαθιστά την εκπαίδευση της ειδικότητας, την εποπτεία, την κλινική κρίση ή τη γνωμάτευση ειδικού.

Επόμενο βήμα

Τώρα ανοίξτε το Γρήγορο μπόνους · Λίστα Ελέγχου Γνωμάτευσης σε Μία Σελίδα. Απάντηση στο κλινικό ερώτημα, πλευρά, μέτρηση, σύγκριση και ενημέρωση: ελέγξτε τα σε ένα λεπτό πριν από την υπογραφή.

Για πλήρη πρότυπα γνωμάτευσης μπορείτε να επιστρέψετε στο **Κύριο υλικό · 120 Έτοιμα Πρότυπα Γνωμάτευσης**.